AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

SALUD PÚBLICA

Epidemiología & Bioética

15 temas · 1 página cada uno · 7 días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Sistema de Salud Chileno, Red Asistencial & Vigilancia Epidemiológica

★★★ 21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial 3

★★☆ 21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos 4

★☆☆ 21.3. Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) 5

★★★ 21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile 6

★☆☆ 21.5. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario 7

★★☆ 21.15. Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección 8

02 Epidemiología Clínica, Bioestadística & Tamizaje

★★★ 21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales 9

★★★ 21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud 11

★★☆ 21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC 12

★★☆ 21.9. Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos 13

★★★ 21.10. Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos 14

03 Bioética Clínica, Medicina Legal & Marco Regulatorio

★☆☆ 21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento 15

★☆☆ 21.12. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad 16

★☆☆ 21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia 17

★★☆ 21.14. Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas 18

Números que tienes que saber 19

GES de la especialidad 20

Plan de repaso de 7 días 21

Índice por prioridad ★ 22

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.036 Organización actual del sistema de salud chileno — Conocimiento general

También: Definición, estructura y funciones de los subsistemas en Chile · Concepto y descripción de la red asistencial chilena · Financiamiento del sector salud · Funciones esenciales de la Salud Pública · Bases conceptuales de la seguridad social · Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud · Funciones de los sistemas de atención de salud · Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile

LO QUE TE PREGUNTAN

- **FONASA Tramo A**: Personas indigentes o sin ingresos; atención **100%** gratuita en MAI; NO tienen acceso a Modalidad Libre Elección (MLE).
- **Copago Cero (desde 2022)**: Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen gratuidad total (**0%** de copago) en toda la Red Pública (MAI).
- **Modalidad Libre Elección (MLE)**: Solo disponible para Tramos B, C y D mediante la compra de bonos en prestadores privados con convenio.
- **Atención Primaria en Salud (APS)**: Puerta de entrada regular obligatoria a la red pública; resuelve entre el **85%** y **90%** de las consultas.
- **SAPU vs SAR**: El SAR dispone de radiología digital osteopulmonar y laboratorio de respuesta rápida (troponinas, hemograma), permitiendo mayor resolutividad ambulatoria que el SAPU.
- **Superintendencia de Salud**: Ente autónomo que supervigila y fiscaliza a FONASA, ISAPRES y prestadores institucionales acreditados.

ALGORITMO · TRAMO Y MODALIDAD: A QUÉ TIENE DERECHO EL PACIENTE

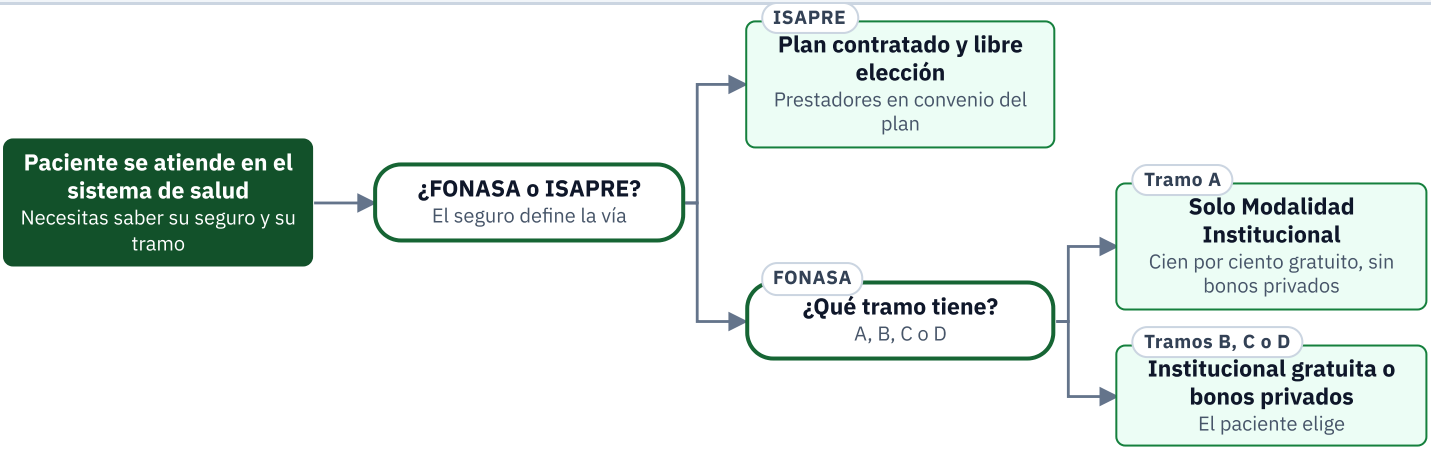


TABLA 21.1 · TRAMOS DE FONASA: CLASIFICACIÓN, INGRESOS Y DERECHOS DE MODALIDAD

TRAMO	NIVEL DE INGRESOS MENSUALES	COPAGO RED PÚBLICA (MAI)	DERECHO A LIBRE ELECCIÓN (MLE)
Tramo A	Carentes de recursos, indigentes, PRAIS	0% (Gratuito)	NO tiene derecho a MLE
Tramo B	≤ 1 Ingreso Mínimo Mensual	0% (Gratuito)	SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3)
Tramo C	> 1 y ≤ 1,46 Ingresos Mínimos (o >3 cargas)	0% (Copago Cero vigente)	SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3)
Tramo D	> 1,46 Ingresos Mínimos	0% (Copago Cero vigente)	SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Laboratorio nacional de referencia	Instituto de Salud Pública	Confundirlo con la Superintendencia de Salud
Fiscaliza a FONASA, ISAPRES y prestadores	Superintendencia de Salud	Responder Ministerio de Salud
Paciente sin patología de urgencia, en la noche	SAPU o SAR según disponibilidad	Ir directo al hospital de alta complejidad

REGLA DE ORO **MINSAL norma, Servicios de Salud administran** — Superintendencia fiscaliza

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **3–12, 37, 41–43** (págs. 10–11, 15–16) · solucionario págs. 25–26, 30–31.

Clase 21.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.040 **Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso** — Conocimiento general

También: Auditoría y acreditación · Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda · Salud oral · Derecho GES a ayudas técnicas para personas de 65 años o más, como órtesis

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Las 4 Garantías GES son**: Acceso, Oportunidad, Protección Financiera y Calidad. Tienen rango de exigibilidad legal directa.
- Todo médico cirujano (público o privado) tiene la obligación legal de emitir el Formulario de Constancia GES ante sospecha o confirmación de un problema cubierto.
- Si se vence la Garantía de Oportunidad, el paciente reclama ante su asegurador (FONASA o ISAPRE), el cual tiene **48 horas** hábiles para designar un Segundo Prestador.
- El Segundo Prestador tiene un plazo legal de **10 días** corridos para otorgar la prestación requerida.
- Si el asegurador o el segundo prestador no responden en los plazos, el paciente acude a la Superintendencia de Salud, que designa un prestador en **48 horas**.
- **Protección Financiera en ISAPRE**: Copago máximo **20%** con deducible máximo anual de 29 cotizaciones legales o 122 UF por evento.

ALGORITMO · LAS CUATRO GARANTÍAS: CUÁL SE APLICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

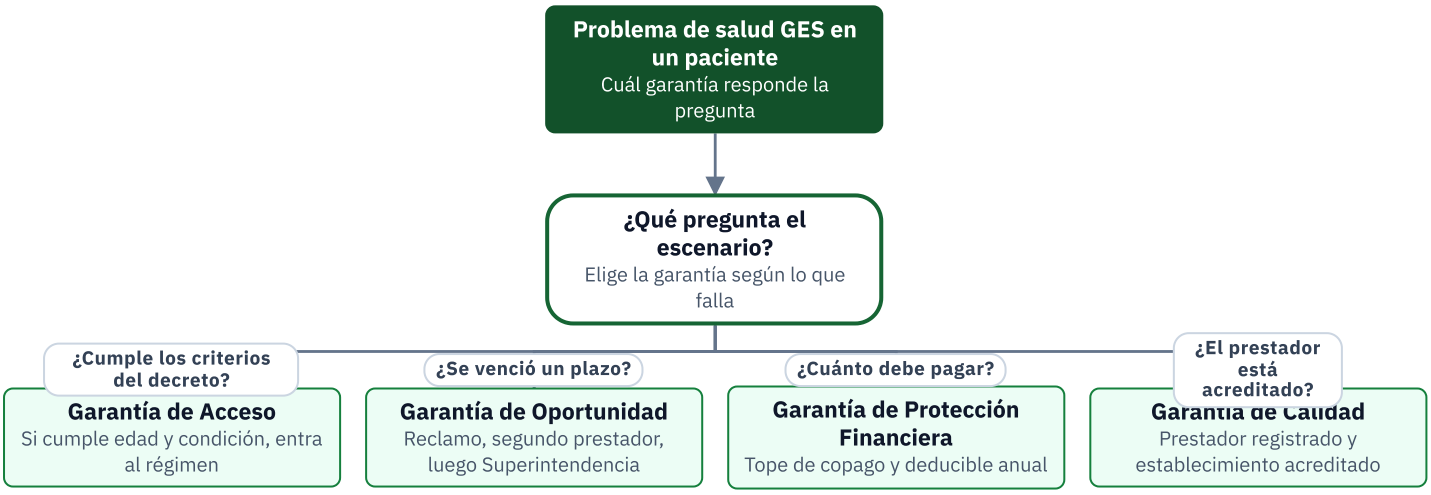


TABLA 21.2 · LAS 4 GARANTÍAS LEGALES DEL RÉGIMEN GES (LEY 19.966)

GARANTÍA	DEFINICIÓN LEGAL	MECANISMO DE EXIGIBILIDAD	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO
Acceso	Derecho a recibir atención si cumple criterios de inclusión	Ingreso en prestador de la Red GES oficial	Reclamo y obligatoriedad de ingreso forzoso
Oportunidad	Plazo máximo para diagnóstico, tratamiento y seguimiento	Cronograma estricto en Guías Clínicas GES	Designación de 2.° prestador en 48 h; luego Superintendencia
Protección Financiera	Copago máximo 20% (0% en FONASA) y Deducible tope	Mecanismo de pago por canasta y deducible anual	Reembolso inmediato de cualquier cobro improcedente
Calidad	Atención por profesionales y centros acreditados	Superintendencia de Salud (Registro de Prestadores)	Invalidez legal de la prestación y sumario sanitario

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	GARANTÍA VULNERADA	ERROR FRECUENTE
Prestador sin acreditación otorga cirugía GES	Garantía de Calidad	Decir que no hay vulneración porque la cirugía salió bien
Paciente de 58 años sin criterio etario GES	Ninguna: no cumple Garantía de Acceso	Decir que se vulneró la Garantía de Oportunidad
Plazo de cirugía GES vencido en el hospital	Garantía de Oportunidad	Ir directo a un recurso judicial

REGLA DE ORO **Acceso: si cumples el criterio, entras** — Oportunidad: los plazos

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **13, 39** (págs. 12, 16) · solucionario págs. 27, 30.

Clase 21.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

21.3 Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.040 **Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso** — Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ley Ricarte Soto**: Protección financiera universal para fármacos y dispositivos de alto costo; cubre a FONASA, ISAPRES, FFAA y particulares.
- **Copago en Ley Ricarte Soto**: Es **100%** gratuita para el beneficiario (**0%** de copago).
- **PNAC Universal**: Los niños menores de **6 años** y gestantes pueden retirar los alimentos del PNAC en el CESFAM sin importar si son FONASA o ISAPRE.
- **Alimentos del PNAC**: Purita Fortificada (**6-17 meses**), Purita Cereal (**18 meses** a **5 años 11 meses**) y Purita Mamá (embarazo y lactancia).
- **PACAM**: Beneficio para adultos de **70 años** o más en FONASA; entrega Crema Años Dorados y Bebida Láctea; exige EMPAM al día.
- **PNAC Especiales**: Cubre fórmulas hidrolizadas/aminoácidos en APLV y fórmulas para prematuros menores de **32 semanas** o **1.500 g**.

ALGORITMO · A QUÉ BENEFICIO CORRESPONDE CADA PACIENTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

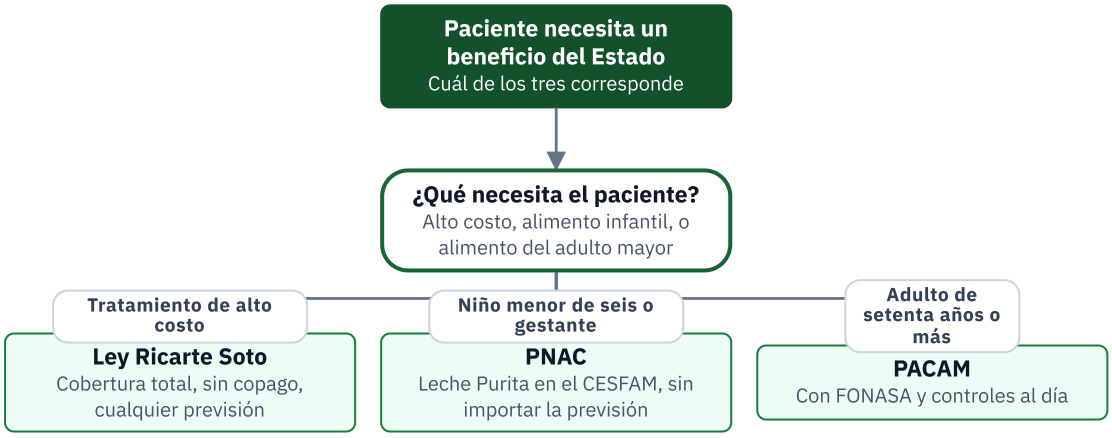


TABLA 21.3 · COMPARACIÓN: LEY RICARTE SOTO VS RÉGIMEN GES

CARACTERÍSTICA	LEY RICARTE SOTO (LEY 20.850)	RÉGIMEN GES (LEY 19.966)
Población Objetivo	100% Universal (FONASA, ISAPRES, FFAA y sin previsión)	Afiliados a FONASA e ISAPRES
Criterio de Inclusión	Alto costo financiero que supera el umbral económico nacional	Prioridad sanitaria, morbimortalidad y años de vida perdidos
Copago del Usuario	0% Gratuito siempre para todos los beneficiarios	Copago máximo 20% (según seguro y tramo)
Tipos de Prestaciones	Fármacos de alto costo, insumos y dispositivos específicos	Canastas integrales (diagnóstico, cirugía, hospitalización, fármacos)
Garantías Legales	Protección financiera integral para lo aprobado	Las 4 garantías legales (Acceso, Oportunidad, Protección y Calidad)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fármaco de alto costo en paciente ISAPRE	Cobertura cien por ciento por Ley Ricarte Soto	Decir que solo aplica a FONASA
Copago en tratamiento Ricarte Soto	Cero por ciento, siempre	Aplicar el tope de veinte por ciento del GES
Niño de ISAPRE, control al día	Puede retirar la leche Purita en el CESFAM	Negar el retiro por no ser de FONASA

REGLA DE ORO **Cubre a todos, sin importar el seguro** — FONASA, ISAPRE, FFAA o sin previsión

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, pregunta **44** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

Clase 21.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

21.4 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.016 **Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes** — Conocimiento general

También: Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades · Estrategias de control de enfermedades infecciosas · Usos de la epidemiología en el control de enfermedades · Investigación epidemiológica

LO QUE TE PREGUNTAN

- Las ENO Inmediatas se notifican ante la simple SOSPECHA clínica por la vía más rápida (Epivigila/teléfono); ¡nunca esperar confirmación de laboratorio!
- **Son ENO Inmediatas clásicas**: Meningococo, Hantavirus, Sarampión, Rubéola, Cólera, Botulismo, Rabia, Ántrax y brotes de ETA.
- **Son ENO Diarias**: Tuberculosis, Sífilis, VIH, Gonorrea, Hepatitis A, B y C, Coqueluche, Chagas y Tétanos.
- **Contactos de Meningococo**: Profilaxis con Rifampicina (**600 mg** c/**12 h** x 2 d) o Ciprofloxacino (**500 mg** VO DU); en embarazadas usar Ceftriaxona (**250 mg** IM DU).
- **Brotes de ETA**: La presencia de 2 o más personas con sintomatología digestiva similar tras compartir un alimento común constituye una ENO Inmediata.

ALGORITMO · INMEDIATA, DIARIA O CENTINELA: CÓMO SE DECIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 21.4 · ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA: INMEDIATA VS DIARIA

CATEGORÍA	MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	VÍA DE COMUNICACIÓN	EJEMPLOS CARDINALES DE ENFERMEDADES
ENO Inmediata	Ante la simple SOSPECHA clínica (no esperar laboratorio)	Vía más rápida disponible (teléfono/Epivigila inmediato)	Meningococo, Hanta, Rabia, Sarampión, Cólera, Botulismo, Ántrax, Mpox, Brote ETA
ENO Diaria	Dentro de las 24 horas de confirmación o sospecha	Plataforma Epivigila / Formulario oficial diario	TBC, Sífilis, VIH, Gonorrea, Hepatitis A/B/C, Coqueluche, Chagas, Tétanos, Hidatidosis
Vigilancia Centinela	Muestreo poblacional periódico según centros centinela	Plataforma de vigilancia ministerial	Influenza, Virus Respiratorio Sincicial (VRS), Diarreas por Rotavirus

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

TIPO DE VIGILANCIA	CUÁNDO SE NOTIFICA	EJEMPLOS
Notificación diaria	Dentro de veinticuatro horas de confirmar o sospechar	Tuberculosis, sífilis, VIH, hepatitis, coqueluche
Brote de hepatitis A confirmado	Notificación diaria a la SEREMI	Confundirla con una enfermedad de notificación inmediata
Brote en un banquete: grupo cerrado	Cohorte con tasa de ataque y riesgo relativo	Hacer casos y controles

REGLA DE ORO **Grave y poco frecuente** — Notificación inmediata, ante la sola sospecha

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **14–15, 19–22** (págs. 12–13) · solucionario págs. 27–28.

Clase 21.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

21.5 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

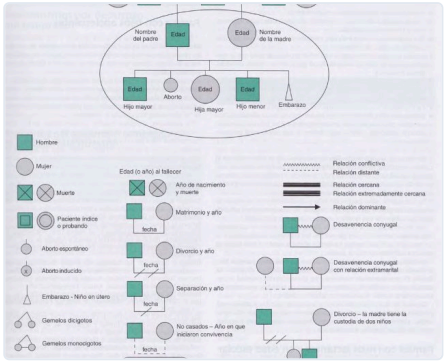
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
6 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.008 Diagnóstico de situación de salud: — Conocimiento general

También: Etapas del diagnóstico de situación de salud · Familia y ciclo vital · Conceptos y definiciones de Salud Pública · Promoción de salud y prevención de enfermedades · Determinantes del nivel de salud · Ejecución de un diagnóstico · Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud · Criterios de priorización de problemas

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Principios del MAIS**: Centrado en las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado.
- **Genograma**: Mínimo 3 generaciones familiares; grafica edades, vínculos, fallecimientos y antecedentes mórbidos.
- **Ecomapa**: Muestra las relaciones y redes de apoyo de la familia con el entorno comunitario (escuela, trabajo, CESFAM).
- **APGAR Familiar**: Puntaje 7-10 (funcional), 4-6 (disfunción leve), 0-3 (disfunción severa). Evalúa adaptabilidad, participación, gradiente, afecto y resolución.
- **ASIS (Análisis de Situación de Salud)**: Proceso continuo que combina indicadores cuantitativos con diagnóstico participativo con la comunidad.



GENOGRAMA Y SÍMBOLOS
Meneghello Pediatría, 6.ª ed., Fig. 3-1, p. 38

ALGORITMO · QUÉ INSTRUMENTO DEL MAIS CORRESPONDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

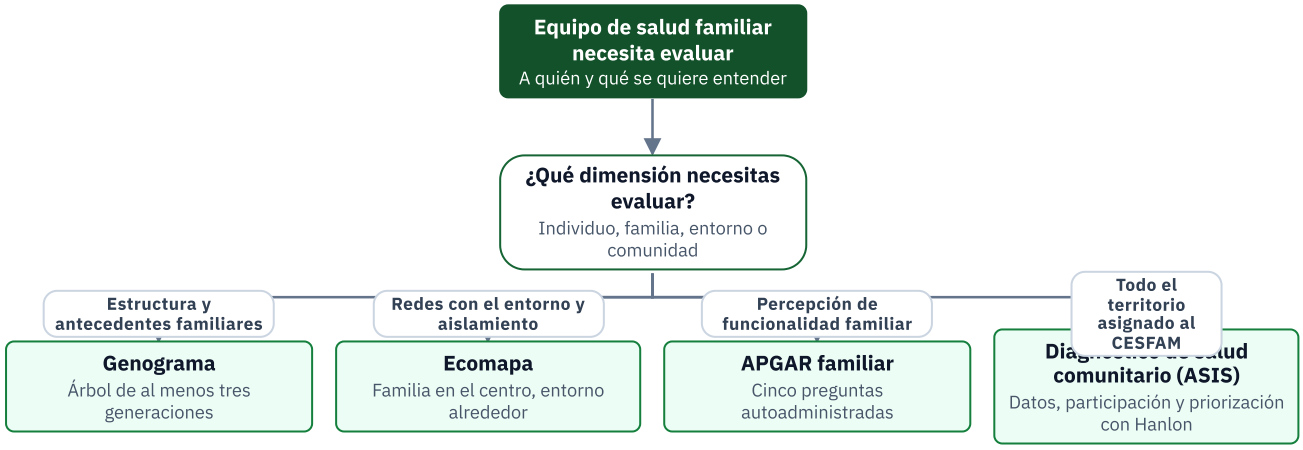


TABLA 21.5 · INSTRUMENTOS DE SALUD FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA

INSTRUMENTO	ESTRUCTURA Y COMPONENTES	OBJETIVO CLÍNICO-ASISTENCIAL	PUNTAJE / INTERPRETACIÓN
Genograma	Árbol gráfico de 3 generaciones con símbolos estandarizados	Visualizar estructura biológica, patologías y vínculos	Estructural, dinámico y relacional
Ecomapa	Círculo familiar central rodeado de sistemas comunitarios	Evaluar redes de apoyo social y fuentes de estrés	Vínculos fuertes, débiles o estresantes
APGAR Familiar	5 preguntas (Adaptación, Participación, Ganancia, Afecto, Recursos)	Medir percepción de satisfacción y funcionalidad familiar	7-10: Buena función; 4-6: Disfunción leve; 0-3: Disfunción severa
Círculo Familiar	Círculo en blanco donde el usuario dibuja a sus miembros	Explorar cercanía emocional y jerarquías subjetivas	Apreciación cualitativa gráfica del paciente

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

INSTRUMENTO	QUÉ MIRA	OBJETIVO	PUNTAJE O LECTURA
ASIS	Toda la comunidad del sector	Priorizar problemas de salud con el método de Hanlon	Diagnóstico participativo, no un test individual
Ciclo vital de Duvall	Etapa de la familia	Anticipar problemas y crisis esperables	Ocho etapas; el cambio de etapa es crisis normativa
Método de Hanlon	Problemas de la comunidad	Priorizar con A más B, por C, por D	Si la factibilidad D es cero, no es prioritario

REGLA DE ORO **Estructura y vínculos internos** — Genograma

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **16–17, 23–28, 45** (págs. 12–14, 17) · solucionario págs. 27–29, 31.

Clase 21.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

21.15 Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.007 **Demografía y salud pública** — Conocimiento general

También: Conceptos de administración y gestión · Planificación y programación en salud · Formulación de programas · Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones · Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación · Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Proceso administrativo**: planificar, organizar, dirigir y controlar (evaluar); la evaluación retroalimenta la planificación.
- **Objetivo**: qué se quiere lograr; meta: cuánto y para cuándo (medible y con plazo).
- **Marco lógico**: fin, propósito, componentes y actividades, con indicadores, medios de verificación y supuestos.
- **Organización**: unidad de mando, jerarquía, tramo de control, división del trabajo; el organigrama representa la estructura formal.
- **Dirección**: liderazgo (autocrático, democrático, laissez-faire), motivación, comunicación y coordinación.
- **Índice ocupacional** = días cama ocupados / días cama disponibles × 100; giro de camas = egresos / camas; estada = días de estada / egresos.
- Pirámide expansiva (base ancha), estacionaria (campana) y constrictiva (base angosta, envejecimiento); Chile tiene población que envejece.

ALGORITMO · DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN A LAS MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA

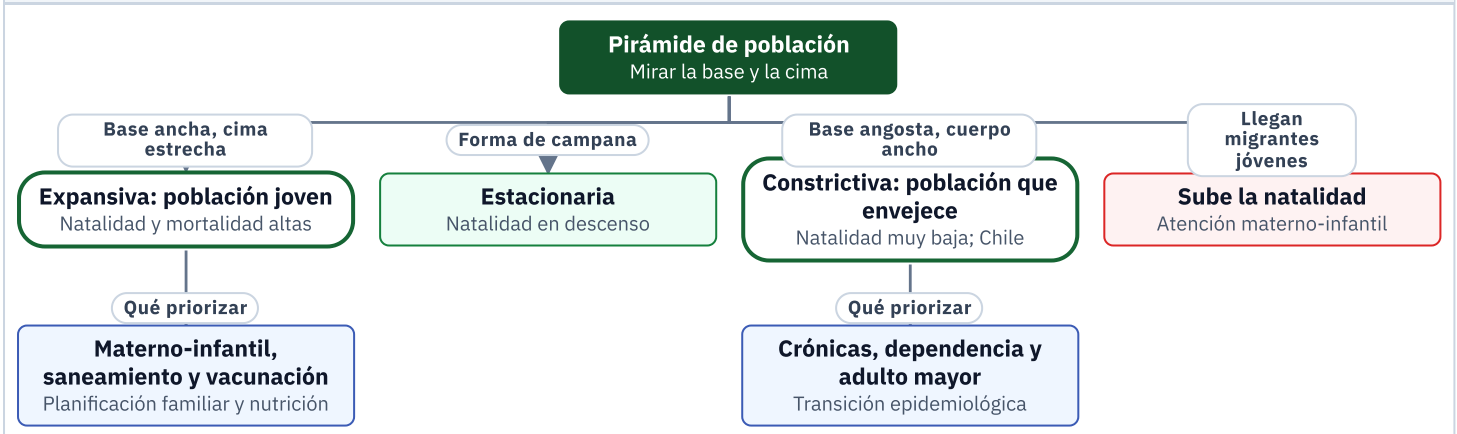


TABLA 21.15 · LAS FUNCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

FUNCIÓN	PREGUNTA QUE RESPONDE	HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS	EJEMPLO EN UN CESFAM
Planificación	¿Qué haremos y cómo?	Diagnóstico, FODA, objetivos, metas, plan	Plan anual para subir la cobertura de control de hipertensos
Programación	¿Cuántas actividades y con qué recursos?	Concentración, rendimiento, carta Gantt	Horas médicas y de enfermería para 600 hipertensos
Organización	¿Quién hace qué?	Organigrama, división del trabajo, tramo de control	Equipos de cabecera por sector con un jefe
Dirección	¿Cómo se pone en marcha al equipo?	Liderazgo, motivación, comunicación, coordinación	Reuniones de equipo y retroalimentación
Evaluación y control	¿Se logró lo planificado?	Indicadores de estructura, proceso y resultado	Porcentaje de hipertensos compensados

REGLA DE ORO **Base ancha: infecciosas y materno-infantil** — Base angosta: crónicas y envejecimiento

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **55, 73** (págs. 18, 21) · solucionario págs. 33, 37.

Clase 21.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

Máxima Rentabilidad · Pregunta fija en cada EUNACOM diferenciando Casos y Controles vs Cohortes vs Transversal vs ECA

7.01.3.020 **Diseños de investigación epidemiológica** — Conocimiento general

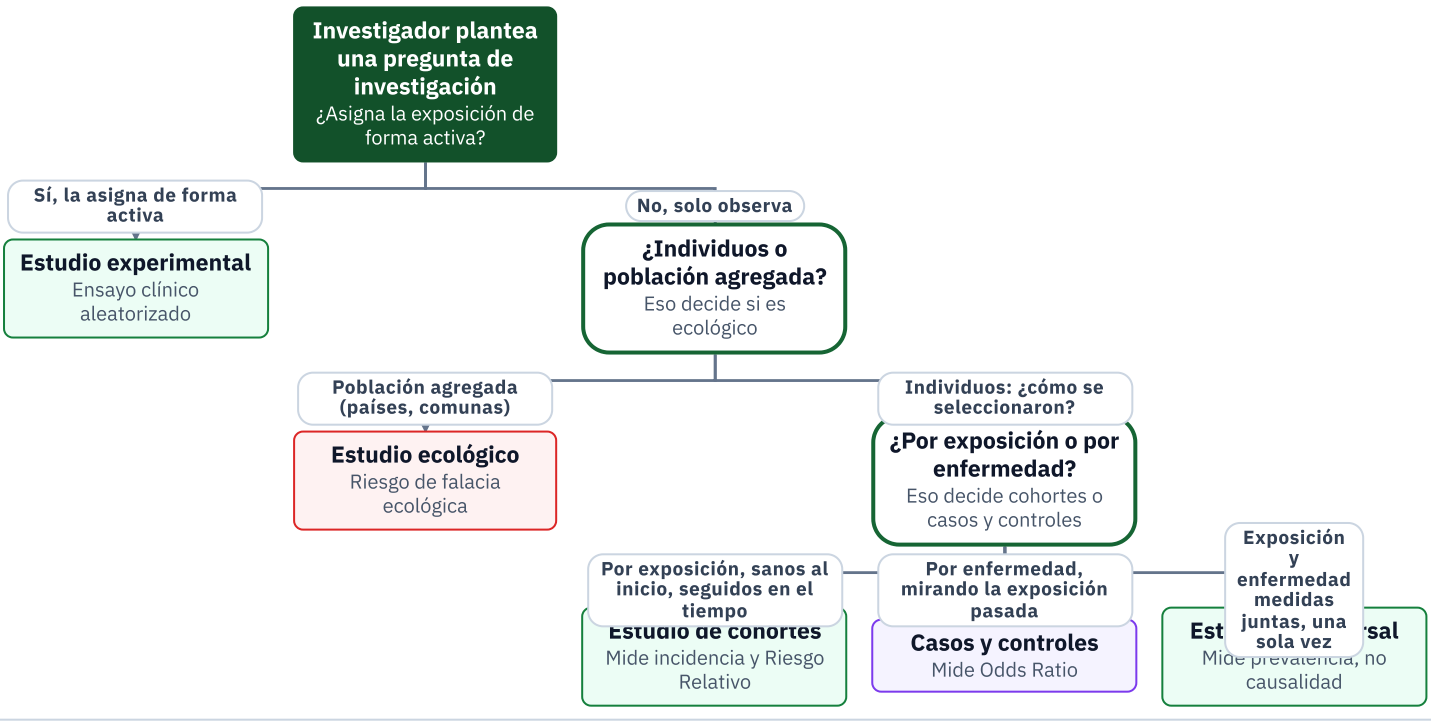
También: Estudios de casos y controles · Estudios de cohortes · Estudios experimentales y cuasiexperimentales · Concepto y campo de la epidemiología · Epidemiología analítica · Estudios de prevalencia · Concepto de estudios ecológicos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Casos y Controles**: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para patologías raras; medida: Odds Ratio (OR).
- **Cohortes**: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento; mide Incidencia directa y Riesgo Relativo (RR); óptimo para exposiciones raras.
- **Transversal**: Exposición y enfermedad medidas simultáneamente; calcula Prevalencia; NO permite probar causalidad por ambigüedad temporal.
- ECA: Estándar de oro de causalidad terapéutica; la aleatorización neutraliza factores de confusión conocidos y desconocidos.
- **Estudio Ecológico**: Unidad de análisis agregada (poblaciones, países); susceptible a la Falacia Ecológica (atribuir a individuos lo observado en grupos).
- **Fases de ECA**: Fase I (seguridad en sanos), Fase II (dosis en enfermos), Fase III (eficacia y registro frente a estándar), Fase IV (farmacovigilancia).

ALGORITMO · QUÉ DISEÑO DE ESTUDIO CORRESPONDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **18, 29–36** (págs. 12, 14–15) · solucionario págs. 27, 29–30.

Clase 21.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

21.6 Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 21.6 · COMPARACIÓN METODOLÓGICA CARDINAL ENTRE DISEÑOS EPIDEMIOLÓGICOS

DISEÑO DE ESTUDIO	CRITERIO DE SELECCIÓN	DIRECCIÓN TEMPORAL	MEDIDA DE FRECUENCIA	MEDIDA DE ASOCIACIÓN
Transversal	Muestra poblacional general	Un solo momento (simultáneo)	Prevalencia	Razón de Prevalencias / Odds Ratio
Casos y Controles	Por Enfermedad (Casos vs Controles)	Retrospectiva hacia el pasado	Proporción de expuestos	Odds Ratio (OR)
Cohortes	Por Exposición (Expuestos vs No Expuestos)	Longitudinal / Seguimiento en tiempo	Incidencia (IA o DI)	Riesgo Relativo (RR)
Ensayo Clínico (ECA)	Asignación aleatoria por investigador	Prospectivo experimental controlado	Incidencia del evento	Riesgo Relativo / Reducción Riesgo
Ecológico	Poblaciones completas (países, comunas)	Corte o series temporales	Tasas brutas poblacionales	Coeficiente de Correlación (r)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	DISEÑO ÓPTIMO	PRINCIPAL RIESGO DE SESGO
Enfermedad muy rara	Casos y controles	Sesgo de memoria al recordar la exposición
Exposición infrecuente	Cohortes	Pérdidas de seguimiento de los sujetos
Eficacia de un fármaco nuevo	Ensayo clínico aleatorizado doble ciego	Pérdida de validez externa si los criterios son muy estrictos

REGLA DE ORO **Por exposición, sanos al inicio** — Cohortes

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La identificación precisa del diseño de un estudio epidemiológico a partir de una viñeta clínica metodológica es una de las preguntas cardinales de Salud Pública en el examen EUNACOM. Reconocer el criterio de selección de los participantes (por exposición en cohortes vs por enfermedad en casos y controles), la temporalidad (longitudinal vs transversal), la unidad de análisis (individual vs agregada en ecológicos) y el control de la exposición (observacional vs experimental aleatorizado) permite deducir inmediatamente la medida de asociación calculable y sus posibles sesgos.

TABLA 21.6.B · FASES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA

FASE	POBLACIÓN SUJETO	OBJETIVO PRIMARIO	DISEÑO HABITUAL
Fase I	20 a 80 voluntarios sanos	Seguridad, toxicidad, dosis máxima y farmacocinética	Abierto, no comparativo
Fase II	100 a 300 pacientes con la enfermedad	Eficacia preliminar, curva dosis-respuesta y seguridad	Controlado, con o sin aleatorización
Fase III	1.000 a 3.000+ pacientes con la patología	Confirmar eficacia frente a estándar o placebo (aprobación ISP/FDA)	ECA multicéntrico, aleatorizado, doble ciego
Fase IV	Población general que consume el fármaco	Farmacovigilancia post-comercialización, RAMs raras	Estudios observacionales a gran escala

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **18, 29–36** (págs. 12, 14–15) · solucionario págs. 27, 29–30.

Clase 21.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

★★★ PRIORIDAD ALTA
32 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.019 Medidas de asociación e impacto — Conocimiento general

También: Epidemiología descriptiva · Mortalidad perinatal y materna · Salud pública perinatal · Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación · Descripción sistemática de problemas · Salud infantil en Chile y el mundo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Incidencia**: Casos nuevos en población libre de enfermedad en un período; Prevalencia: Casos totales existentes en un momento.
- **Riesgo Relativo (RR)**: Incidencia expuestos / Incidencia no expuestos; se calcula únicamente en Cohortes y Ensayos Clínicos.
- **Odds Ratio (OR)**: Razón de productos cruzados (a*d)/(b*c); se calcula en Casos y Controles.
- **Reducción Absoluta del Riesgo (RRA)**: Rc - Rt (diferencia matemática entre incidencias).
- **Número Necesario a Tratar (NNT)**: 1 / RRA (o 100 / RRA en porcentaje); siempre redondear al entero superior.
- **Significancia en IC 95%**: Si el intervalo de un RR u OR incluye el 1,0, NO existe significancia estadística (p **≥ 0,05**).

ALGORITMO · QUÉ MEDIDA CALCULAR Y CÓMO LEERLA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

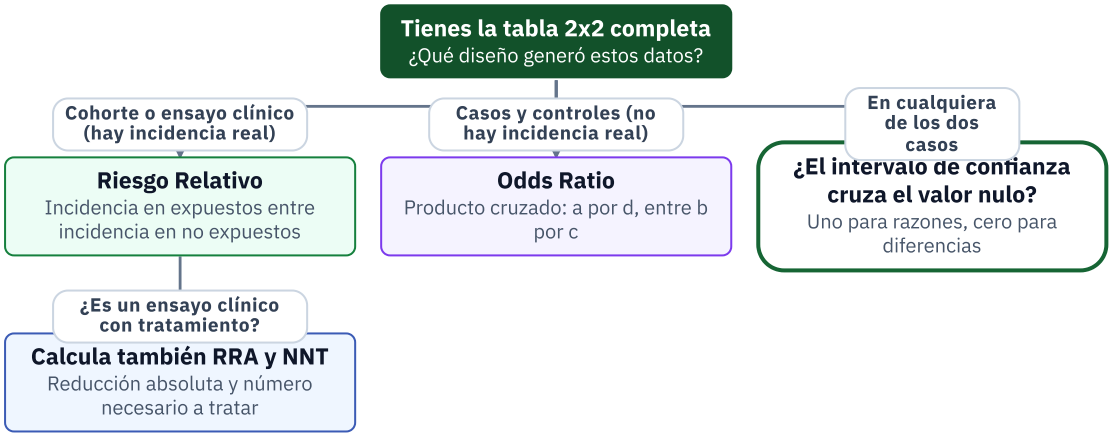


TABLA 21.7 · FORMULARIO ESENCIAL DE BIOESTADÍSTICA EUNACOM

CONCEPTO	FÓRMULA MATEMÁTICA	INTERPRETACIÓN CLÍNICA	DISEÑO APLICABLE
Incidencia Acumulada (IA)	Casos nuevos / Población en riesgo al inicio	Probabilidad de enfermar en un período	Cohortes / Poblacional
Riesgo Relativo (RR)	[a/(a+b)] / [c/(c+d)] = I_exp / I_no_exp	Fuerza de asociación causal o protectora	Cohortes / Ensayos Clínicos
Odds Ratio (OR)	(a · d) / (b · c)	Razón de momios de exposición	Casos y Controles
Reducción Absoluta (RRA)	Rc - Rt (Incidencia control - Incidencia tto)	Beneficio neto real en la población	Ensayos Clínicos (ECA)
Reducción Relativa (RRR)	(Rc - Rt) / Rc = 1 - RR	Porcentaje del riesgo basal eliminado	Ensayos Clínicos (ECA)
Número Necesario a Tratar	NNT = 1 / RRA (o 100 / RRA%)	Pacientes a tratar para evitar 1 evento adverso	Ensayos Clínicos (ECA)

TRAMPAS EUNACOM

TE PREGUNTAN POR...	MEDIDA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cuántas veces más riesgo hay en cohorte o ensayo	Riesgo Relativo	Calcular Odds Ratio sin que sea casos y controles
La asociación en un estudio de casos y controles	Odds Ratio	Decir que el Odds Ratio es directamente el riesgo
El beneficio real de un tratamiento	Reducción absoluta y número necesario a tratar	Quedarse solo con la reducción relativa

REGLA DE ORO **Cohorte o ensayo clínico** — Riesgo Relativo

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **2, 46–48** (págs. 10, 17) · solucionario págs. 25, 32.

Clase 21.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

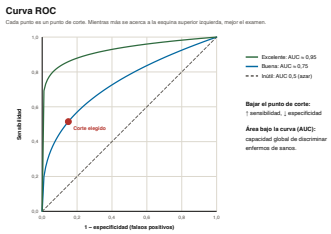
21.8 Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.028 Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas — Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Sensibilidad**: Capacidad del test para detectar enfermos = VP / (VP + FN); alta sensibilidad con resultado negativo descarta la patología.
- **Especificidad**: Capacidad del test para identificar sanos = VN / (VN + FP); alta especificidad con resultado positivo confirma la patología.
- **Valores Predictivos**: VPP = VP / (VP + FP); VPN = VN / (VN + FN). Dependen directamente de la prevalencia de la enfermedad.
- **Efecto de la prevalencia**: A mayor prevalencia ➔ mayor VPP y menor VPN. A menor prevalencia ➔ menor VPP y mayor VN.
- **Curvas ROC**: Gráfico de Sensibilidad (eje Y) vs 1 - Especificidad (eje X); mide la capacidad discriminativa global de un test continuo.
- **Área Bajo la Curva (AUC)**: AUC de 0,5 equivale al azar; AUC > 0,90 indica un test con excelente capacidad diagnóstica.



CURVA ROC
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · QUÉ PARÁMETRO CALCULAR Y CÓMO INTERPRETARLO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

Tienes la tabla 2x2 frente al patrón de oro
¿Qué te preguntan: el test o la población?

Propiedad del test, no cambia con la población
¿Detectar enfermos o detectar sanos?
Sensibilidad o especificidad

- **Detectar enfermos (para tamizaje)** → **Sensibilidad**: Verdadero positivo entre verdadero positivo más falso negativo
- **Detectar sanos (para confirmar)** → **Especificidad**: Verdadero negativo entre verdadero negativo más falso positivo

Lo que significa el resultado en este paciente
¿Cuál es la prevalencia en esta población?
Eso decide el VPP y el VPN

- **Prevalencia alta (especialidad, brote)** → **VPP alto, VPN más bajo**: Un positivo casi siempre es real
- **Prevalencia baja (tamizaje masivo)** → **VPP bajo, VPN alto**: Un positivo suele ser falso positivo

TABLA 21.8 · TABLA DE CONTINGENCIA 2X2 Y DEFINICIONES MATEMÁTICAS

RESULTADO DE LA PRUEBA	ENFERMOS (GOLD STANDARD +)	SANOS (GOLD STANDARD -)	TOTAL HORIZONTAL
Prueba Positiva (+)	Verdaderos Positivos (VP)	Falsos Positivos (FP)	Total Test (+) = VP + FP
Prueba Negativa (-)	Falsos Negativos (FN)	Verdaderos Negativos (VN)	Total Test (-) = FN + VN
Total Vertical	Total Enfermos = VP + FN	Total Sanos = FP + VN	Población Total = N
Cálculo Intrínseco	Sensibilidad = VP / (VP + FN)	Especificidad = VN / (VN + FP)	Independiente de prevalencia
Cálculo Extrínseco	VPP = VP / (VP + FP)	VPN = VN / (VN + FN)	Depende de la prevalencia

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	PREVALENCIA	COMPORTAMIENTO DEL VPP Y EL VPN
Tamizaje poblacional masivo	Baja	VPP baja mucho, muchos falsos positivos; VPN sube, cerca del cien por ciento
Consulta de especialidad hospitalaria	Alta	VPP sube fuerte, pocos falsos positivos; VPN baja
Sensibilidad y especificidad del mismo test	No cambian	Se mantienen iguales en ambos escenarios

REGLA DE ORO **Sensibilidad y especificidad no cambian** — Son propiedades del test, no de la población

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **49–51** (págs. 17–18) · solucionario págs. 32–33.

Clase 21.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

21.9 Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

Alta · Evalúa tipos de sesgos (selección, memoria, Berkson), el fenómeno de confusión (confounding) y los criterios de causalidad de Hill

7.01.3.026 **Causalidad y sesgos** — Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Error Aleatorio**: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se evalúa con valor p e IC **95%**.
- **Error Sistemático (Sesgo)**: Falla de diseño que altera la validez interna; NO se soluciona aumentando la muestra.
- **Sesgo de Memoria (Recall bias)**: Típico de Casos y Controles; el enfermo recuerda más la exposición que el sano.
- **Sesgo de Berkson**: Selección de sujetos en hospitales que distorsiona la frecuencia de factores de riesgo.
- **Variable de Confusión**: Asociada a la exposición, causa independiente del desenlace y NO es paso intermedio; se controla con estratificación o regresión multivariada.
- **Criterios de Bradford Hill**: Temporalidad es el ÚNICO criterio imprescindible (sine qua non); le siguen dosis-respuesta y consistencia.

ALGORITMO · EVALUAR UNA ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA PASO A PASO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

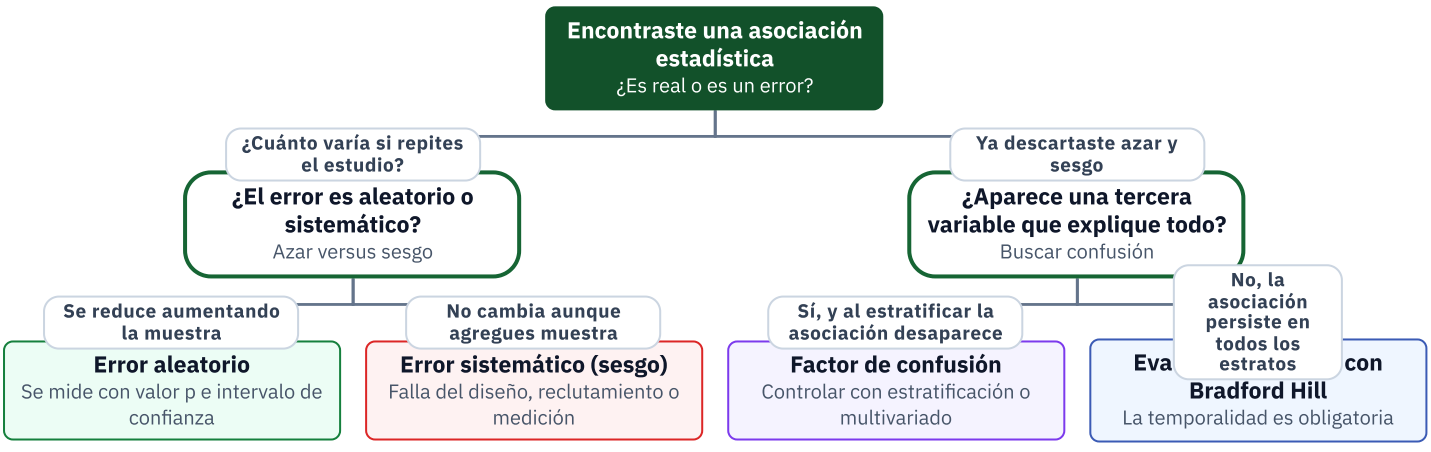


TABLA 21.9 · TIPOS CLÁSICOS DE SESGOS Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN

TIPO DE SESGO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO DEL ERROR	DISEÑO MÁS VULNERABLE	MÉTODO DE CONTROL O PREVENCIÓN
Sesgo de Berkson	Selección de casos y controles en hospitales (mayor morbilidad)	Casos y Controles hospitalarios	Seleccionar controles de base comunitaria o poblacional
Sesgo de Memoria (Recall)	El enfermo recuerda mejor exposiciones pasadas que el sano	Casos y Controles	Usar registros médicos históricos objetivos o cegar al paciente
Sesgo del Entrevistador	El encuestador busca más la exposición si conoce el diagnóstico	Casos y Controles / Cohortes	Enmascaramiento (cegamiento) riguroso del encuestador
Sesgo del Voluntario	Los voluntarios son más motivados y sanos que la media	Ensayos Clínicos / Transversales	Muestreo aleatorio probabilístico representativo
Factor de Confusión	Tercera variable asociada a exposición y causa de enfermedad	Todos los observacionales	Estratificación, pareamiento o análisis multivariado

REGLA DE ORO **El azar se arregla con más muestra** — El sesgo, nunca

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **52–54** (pág. 18) · solucionario pág. 33.

Clase 21.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.028 Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas — Conocimiento general

También: Niveles de prevención · Historia natural de la enfermedad · Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios de Wilson y Jungner**: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
- **Lead-Time Bias (Sesgo de Adelanto)**: Aumento aparente de la sobrevida por adelantar el momento del diagnóstico, sin modificar la fecha de la muerte.
- **Length-Time Bias (Sesgo de Duración)**: Mayor probabilidad de detectar tumores indolentes y de crecimiento lento, sobreestimando falsamente el beneficio del test.
- **Evaluación de Screening**: La eficacia real de un programa de tamizaje se demuestra ÚNICAMENTE con la reducción de la MORTALIDAD, no con la sobrevida a **5 años**.
- **Screening en Chile**: PAP en mujeres **25-64 años** (c/**3 años**), Mamografía en mujeres **50-69 años** (c/**2 años**), PKU/TSH neonatal universal.

ALGORITMO · DECIDIR SI UN PROGRAMA DE TAMIZAJE ESTÁ JUSTIFICADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

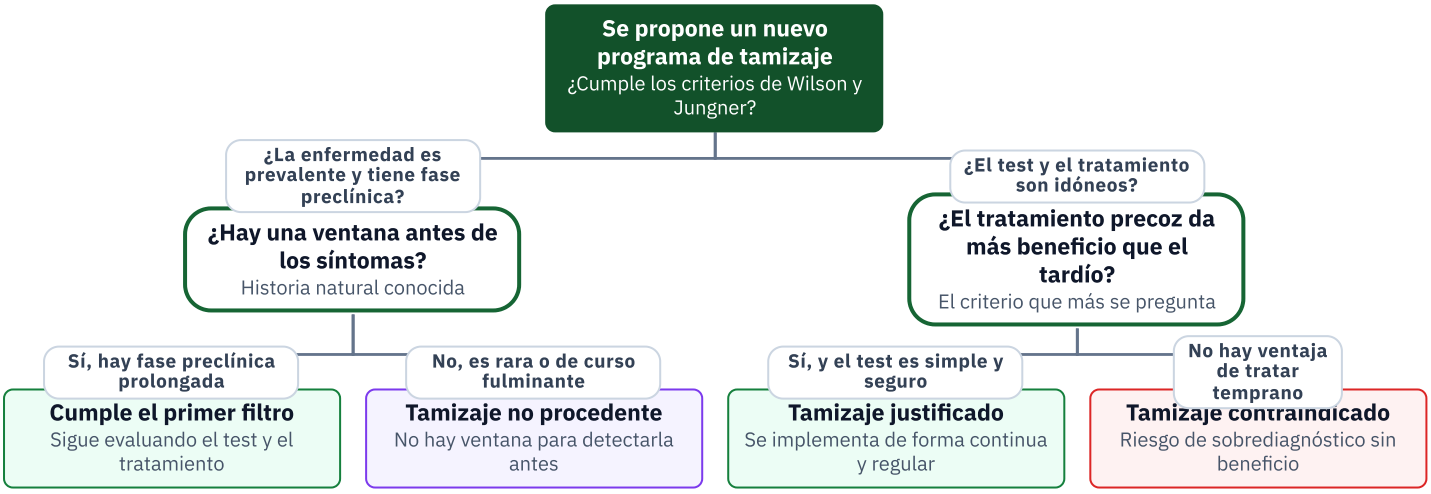


TABLA 21.10 · PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS DE TAMIZAJE EN EL SISTEMA DE SALUD CHILENO

PROGRAMA DE TAMIZAJE	POBLACIÓN OBJETIVO	PRUEBA EMPLEADA	PERIODICIDAD	FASE DETECTABLE
Cáncer Cervicouterino (GES)	Mujeres de 25 a 64 años	Papanicolaou (PAP) / Test VPH	Cada 3 años (PAP) o 5 años (VPH)	Neoplasia Intraepitelial (NIE I-III)
Cáncer de Mama (GES)	Mujeres de 50 a 69 años	Mamografía bilateral	Cada 2 años	Microcalcificaciones / Carcinoma in situ
Hipotiroidismo y Fenilcetonuria	Todos los recién nacidos vivos	Gota de sangre en papel filtro (PKU/TSH)	Al nacer (universal)	Trastorno metabólico antes de secuela
Hipertensión y Diabetes (EMPA)	Adultos de 20 a 64 años	Toma de PA, Glicemia y Colesterol	Cada 3 años en FONASA	Factores de riesgo antes de daño CV
Displasia del Desarrollo de Caderas	Lactantes a los 3 meses	Radiografía de pelvis AP	A los 3 meses de vida universal	Displasia acetabular antes de marcha

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PROGRAMA	POBLACIÓN OBJETIVO	PRUEBA	PERIODICIDAD
Vacuna contra el VPH	Prevención primaria	Llamarla secundaria	Evita que aparezca
Rehabilitación tras un infarto	Prevención terciaria	Llamarla secundaria	Limita el daño

REGLA DE ORO **Fase preclínica detectable** — Y un tratamiento que funcione mejor si se aplica temprano

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **1, 38, 56–61** (págs. 10, 16, 18–19) · solucionario págs. 25, 30, 34–35.

Clase 21.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

21.11 Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.052 **Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial** — Conocimiento general

También: Conocimiento de los derechos y deberes del paciente · Relación médico-paciente-familia

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Principios de Beauchamp y Childress**: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
- **Adulto Competente**: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el médico DEBE respetar su autonomía.
- **Menor de Edad en Riesgo Vital**: Se DEBE transfundir y operar de inmediato; los padres no pueden disponer de la vida del hijo; interponer Medida de Protección.
- **Excepciones al Consentimiento**: Urgencia médica vital con riesgo de muerte/secuela grave en incapaz, y razones de Salud Pública (epidemias).
- **Principio del Doble Efecto**: Permite aumentar opioides en fase terminal para aliviar dolor refractario aunque deprima el sensorio o acorte la vida, si la intención exclusiva es calmar el sufrimiento.
- **Comités de Ética Asistencial (CEA)**: Órganos asesores multidisciplinarios de carácter estrictamente consultivo y NO vinculante.

ALGORITMO · DECIDIR ANTE EL RECHAZO DE UN TRATAMIENTO VITAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

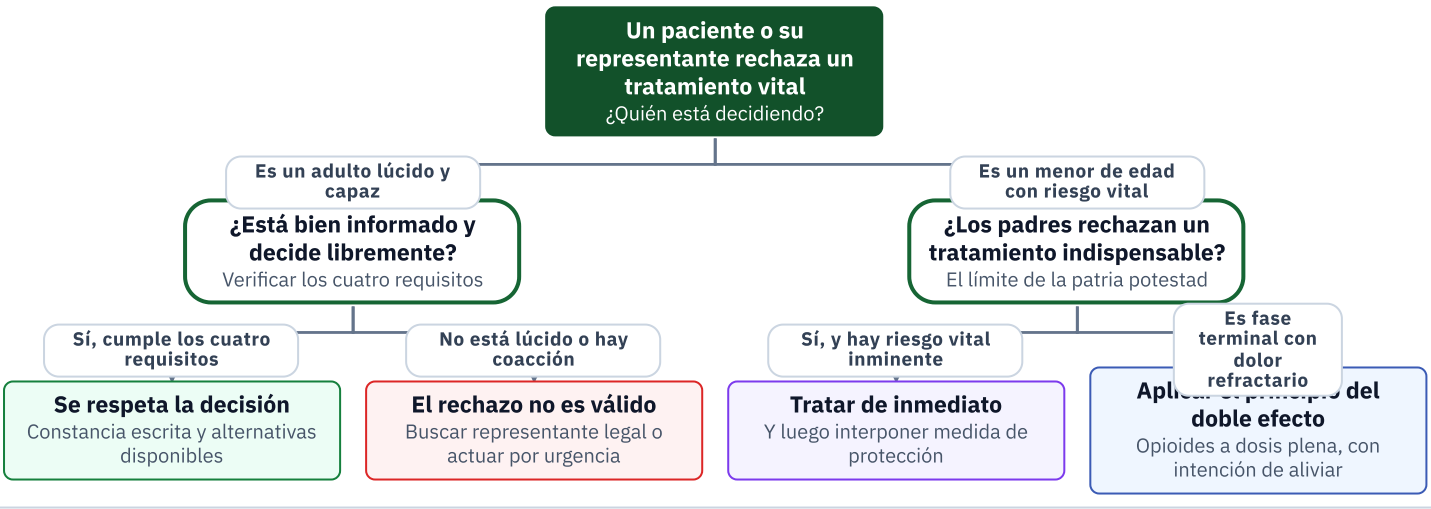


TABLA 21.11 · LOS 4 PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA CLÍNICA DE BEAUCHAMP Y CHILDRESS

PRINCIPIO BIOÉTICO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	APLICACIÓN CLÍNICA EN LA PRÁCTICA	LÍMITES O CONFLICTOS ÉTICOS
Autonomía	Capacidad de autogobernarse y decidir libremente	Consentimiento informado y rechazo de terapias en adultos	Incapacidad mental, coma o daño a terceros
No Maleficencia	Primum non nocere: no infligir daño activo ni omisivo	Evitar futilidad terapéutica y procedimientos dañinos	Prioridad jerárquica en menores con riesgo vital
Beneficencia	Actuar en pro del mayor beneficio para el paciente	Indicación de tratamientos médicos con respaldo clínico	No caer en el paternalismo médico autoritario
Justicia Distributiva	Distribución equitativa y solidaria de recursos de salud	Acceso universal GES y priorización transparente de camas	Triage en desastres y racionamiento de camas críticas

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA OBLIGATORIA	FUNDAMENTO
Adulto lúcido y capaz que rechaza	Respetar; dejar constancia firmada	Prevalece la autonomía, Ley 20.584
Menor de edad en riesgo vital	Transfundir u operar de inmediato	Interés superior del niño y derecho a la vida
Adulto inconsciente, urgencia vital	Actuar de inmediato	Consentimiento presunto, excepción de urgencia

REGLA DE ORO **Adulto competente: manda la autonomía** — Aunque implique riesgo de muerte

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **62–67** (págs. 19–20) · solucionario págs. 35–36.

Clase 21.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

21.12 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

7.01.3.056 Conocimiento de los derechos y deberes del paciente — Conocimiento general

También: Supervisión de salud- adolescente

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
- **Custodia de la Ficha**: El prestador debe conservarla por un plazo MÍNIMO DE 15 AÑOS desde la última atención.
- **Acceso Autorizado**: Paciente, representante legal, herederos del fallecido, tribunales/fiscalía y Superintendencia de Salud.
- **Acceso Prohibido**: Empleadores, aseguradoras sin poder notarial expreso, policías sin orden judicial y familiares de adultos competentes.
- **Trato Digno**: Prohibido fotografiar, grabar en video o exponer al paciente sin consentimiento escrito.
- **Ley de Consultorio Seguro**: Agrava sustancialmente las sanciones penales para quienes agredan verbal o físicamente a los funcionarios de la salud.

ALGORITMO · DECIDIR SI ENTREGAR LA FICHA CLÍNICA A QUIEN LA SOLICITA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

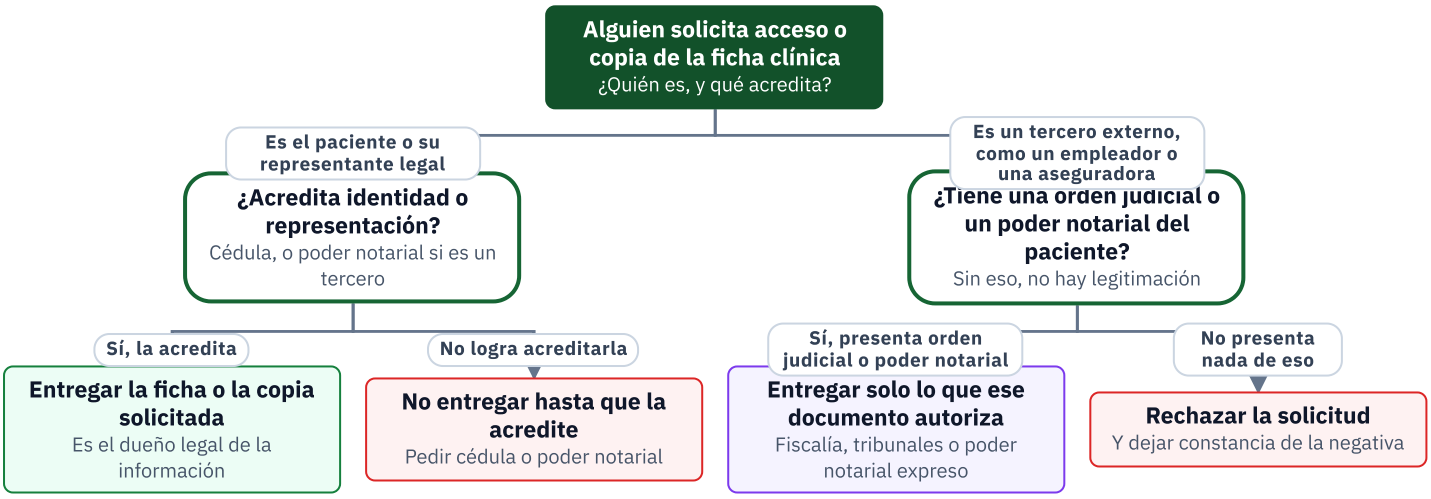


TABLA 21.12 · LEGITIMACIÓN DE ACCESO A LA FICHA CLÍNICA SEGÚN LA LEY 20.584

SOLICITANTE	¿TIENE ACCESO LEGAL DIRECTO?	REQUISITO EXIGIDO POR LEY	EXPLICACIÓN JURÍDICA
El propio Paciente	SÍ	Acreditar identidad con cédula de identidad	Es el dueño legal de su información clínica
Representante Legal	SÍ	Certificado de nacimiento o poder notarial	Actúa en nombre de menor o incapaz
Herederos de Fallecido	SÍ	Certificado de defunción y parentesco / posesión	Continuadores legales de los derechos
Fiscalía / Tribunales	SÍ	Oficio judicial en causa formal en trámite	Requerimiento de la justicia ordinaria
Empleador Laboral	NO	Prohibido absolutamente	Vulneración de datos personales sensibles
Compañía de Seguros	NO (salvo autorización)	Exige poder notarial expreso del paciente	El contrato privado no levanta el secreto médico
Policía (Carabineros/PDI)	NO (sin orden)	Requiere orden del Fiscal o Tribunal	La policía no puede revisar fichas autónomamente

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SOLICITANTE	¿TIENE ACCESO LEGAL?	FUNDAMENTO
Adolescente de 15 años pide anticoncepción y reserva	Se atiende con confidencialidad	Exigir que venga con sus padres
Menor de 14 años con relación sexual	Es delito: denunciar y proteger	Guardar reserva por confidencialidad

REGLA DE ORO **La ficha es del paciente** — El establecimiento solo la custodia

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **68–72** (págs. 20–21) · solucionario págs. 36–37.

Clase 21.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

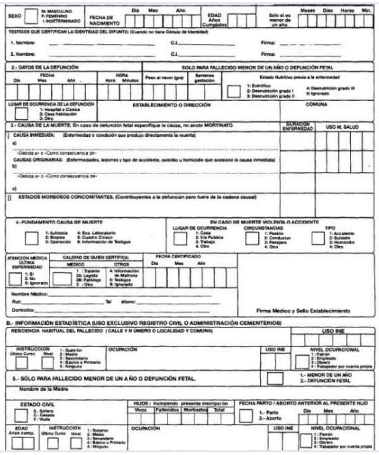
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

7.01.3.051 Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades — Conocimiento general

También: Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial · Maltrato infantil · Violencia intrafamiliar · Fuentes de información para el diagnóstico · Rol del médico en la generación y uso de la información · Prevención de maltrato y abuso infantil

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Causa Básica de Defunción**: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
- **¡PROHIBIDO!**: Nunca escribir 'Paro cardiorrespiratorio', 'Falla multiorgánica' o modos inespecíficos como causa única o básica.
- **Muerte Médico-Legal**: Homicidios, suicidios, accidentes, traumas, sospecha de delito e intoxicaciones; el médico NO firma el CMD.
- **Autopsia del SML**: Ordenada obligatoriamente por el Fiscal; la familia no puede oponerse; el médico legista firma el certificado.
- **Autopsia Clínica**: En muertes naturales hospitalarias con fines científicos; exige consentimiento firmado de la familia.
- **Deber de Denuncia (Art. 175 CPP)**: Obligación de denunciar delitos de acción pública (arma blanca, de fuego, abuso sexual) en un plazo fatal de 24 HORAS.



CERTIFICADO VIGENTE
Manual correcto llenado CMD (ESP U. de Chile / Colegio Médico), Anexo 2

ALGORITMO · CERTIFICAR UNA DEFUNCIÓN: QUÉ FIRMAR Y A QUIÉN AVISAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

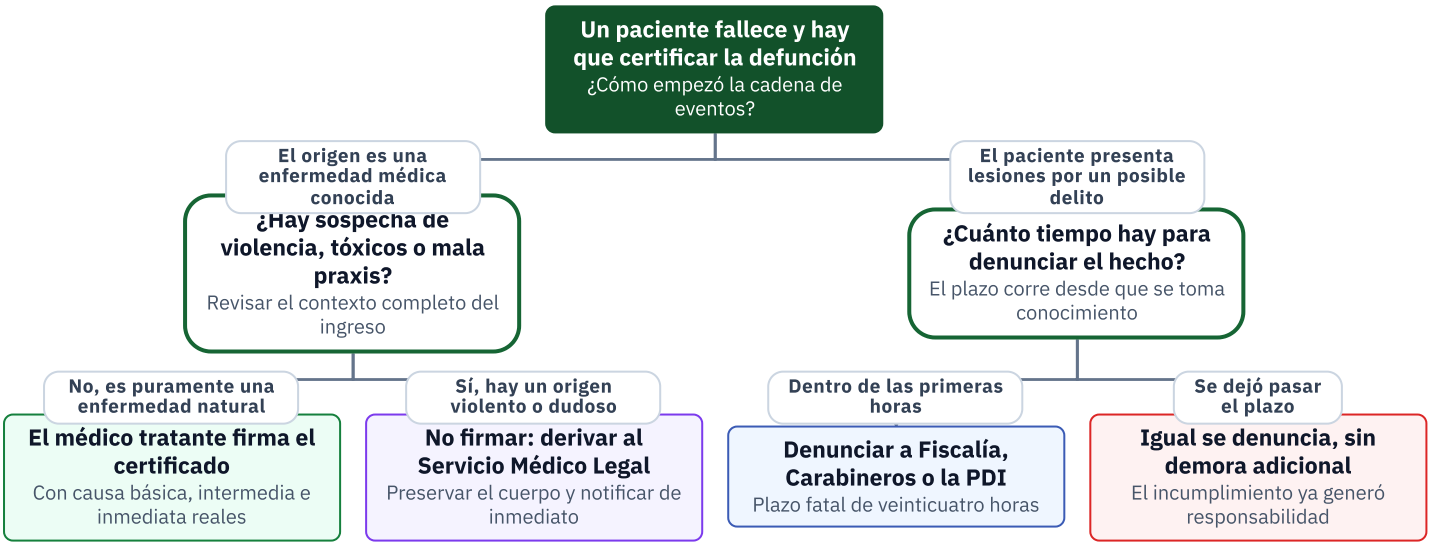


TABLA 21.13 · MUERTE NATURAL VS MUERTE MÉDICO-LEGAL (SML)

CRITERIO DIFERENCIAL	MUERTE NATURAL (CERTIFICABLE)	MUERTE MÉDICO-LEGAL / VIOLENTA (SML)
Causa Originaria	Enfermedades médicas internas conocidas	Trauma, violencia, accidente, suicidio, tóxicos
Quién Firma el CMD	Médico tratante o de cabecera que constata	Exclusivamente el Médico Legista del SML
Lugar de la Autopsia	Hospital (Anatomía Patológica) si se solicita	Servicio Médico Legal (SML) por orden fiscal
Consentimiento Familiar	Exigible para autopsia clínica	NO aplica; la autopsia médico-legal es obligatoria
Rol del Médico Clínico	Completar correctamente el CMD en el INE	NO firmar certificado; llamar a Fiscalía / Carabineros

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CRITERIO	MUERTE NATURAL	MUERTE MÉDICO-LEGAL
Origen violento con muerte hospitalaria tardía	No aplica	Sigue siendo médico-legal, aunque pasen semanas

REGLA DE ORO **Básica, intermedia, inmediata** — Cada una, una enfermedad diagnosticable

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **40, 74–82** (págs. 16, 21–23) · solucionario págs. 31, 37–38.

Clase 21.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta · Pregunta garantizada sobre las 3 causales de la Ley IVE, límites de la objeción de conciencia en urgencia y sanciones por licencias médicas fraudulentas

7.01.3.052 **Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial** — Conocimiento general

También: Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas · Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja · Condiciones de trabajo · Accidentes del trabajo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ley IVE 21.030**: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).
- **Límites gestacionales IVE**: Causal 1 y 2 NO tienen límite gestacional; Causal 3 tiene tope de **12 semanas** (ampliable a **14 semanas** en menores de **14 años**).
- **Objeción de Conciencia**: Debe formularse previamente por escrito; obliga a la derivación inmediata a médico no objetor.
- **Excepción de Urgencia Vital**: En Causal 1 con riesgo de muerte materna inmediata y sin médico de reemplazo, el médico objetor DEBE intervenir forzosamente.
- **Código Sanitario (Art. 112/113)**: Reserva la prescripción diagnóstica y terapéutica exclusiva a médicos cirujanos (y odontólogos/matronas en su campo).
- **Ley 20.585 (Licencias Médicas)**: Penaliza la emisión fraudulenta de licencias médicas con penas de cárcel (presidio), multas millonarias e inhabilitación perpetua.

ALGORITMO · DECIDIR FRENTE A UNA SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

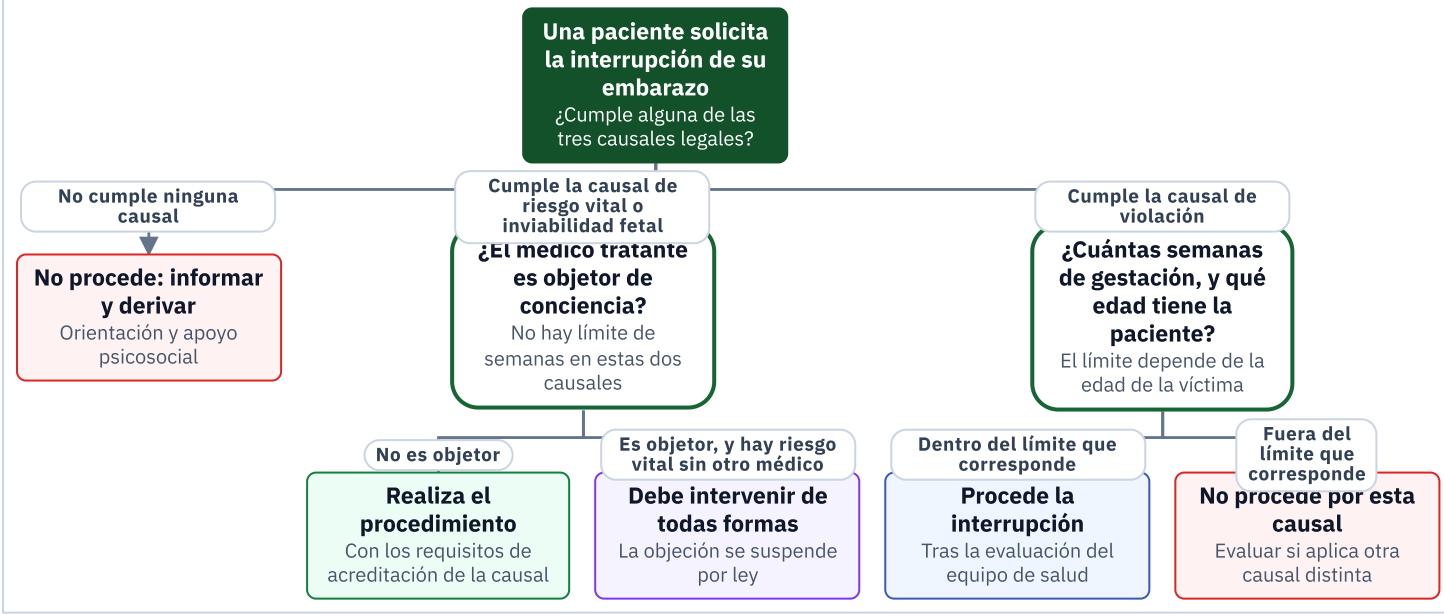


TABLA 21.14 · LAS TRES CAUSALES DE LA LEY IVE 21.030 EN CHILE

CAUSAL LEGAL	DEFINICIÓN MÉDICA	LÍMITE DE EDAD GESTACIONAL	REQUISITOS DE ACREDITACIÓN
Causal 1: Riesgo Vital	Riesgo vital materno actual o inminente	SIN límite de edad gestacional	Médico tratante + 1 especialista (salvo urgencia vital)
Causal 2: Inviabilidad Fetal	Patología congénita incompatible con la vida extrauterina	SIN límite de edad gestacional	Diagnóstico concordante de 2 médicos especialistas
Causal 3: Violación	Embarazo resultante de agresión sexual	Hasta 12 semanas (14 semanas en < 14 años)	Evaluación de equipo psicosocial de salud

REGLA DE ORO **Riesgo vital e inviabilidad: sin límite** — Violación: doce semanas, o catorce en menores

PRACTICA **Libro Gordo Salud Pública**, preguntas **83–90** (págs. 23–24) · solucionario págs. 38–40.

Clase 21.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 15 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
21.1 Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	pág. 3
Financiamiento — Cotización **7%**, impuestos y copagos	CORTE
21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos	pág. 4
Verifica estándares de calidad — Vigencia de **3 años**	CORTE
A los **6 años**: primer molar permanente — Sellantes, obturaciones y alta	CORTE
Anticoncepción y profilaxis — Levonorgestrel y antirretrovirales en **72 horas**	TIEMPO
21.3 Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)	pág. 5
Copago en Ley Ricarte Soto: Es **100%** gratuita para el beneficiario (**0%** de copago).	CORTE
Copago del Usuario · **0%** Gratuito siempre para todos los beneficiarios · Copago máximo **20%** (según seguro y tramo)	CORTE
21.15 Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección	pág. 8
Índice de envejecimiento — **≥ 65 años** / menores de **15 ×** 100	CORTE
Razón de dependencia — (< 15 + **≥ 65**) / población de **15 a 64 ×** 100	CORTE
Chile: fase avanzada — Fecundidad bajo el reemplazo, esperanza de vida cerca de **80 años**	CORTE
BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE	
21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	pág. 11
Hasta **42 días** tras el término — Causa relacionada o agravada por el embarazo; no accidental	TIEMPO
Significancia en IC **95%**: Si el intervalo de un RR u OR incluye el 1,0, NO existe significancia estadística (p **≥ 0,05**).	CORTE
21.8 Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	pág. 12
Área Bajo la Curva (AUC): AUC de 0,5 equivale al azar; AUC > 0,90 indica un test con excelente capacidad diagnóstica.	CORTE
21.9 Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	pág. 13
Error Aleatorio: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se evalúa con valor p e IC **95%**.	CORTE
21.10 Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos	pág. 14
Desconfía de la sobrevida a **5 años** — Puede estar inflada por adelanto o duración	CORTE
BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO	
21.12 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad	pág. 16
Menor de **14 años**: toda relación sexual es delito — Se denuncia y se protege	CORTE
21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	pág. 17
Denunciar en **24 horas** — Y pedir medida de protección al Tribunal de Familia	TIEMPO
Examen completo y estudio por edad — Radiografías de esqueleto en menores de **2 años**; fondo de ojo	CORTE

GES de Salud Pública y Bioética

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

Sin garantía GES específica (15 temas): 21.1 · 21.2 · 21.3 · 21.4 · 21.5 · 21.15 · 21.6 · 21.7 · 21.8 · 21.9 · 21.10 · 21.11 · 21.12 · 21.13 · 21.14. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **21.7** Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud — 11
- ★★★ **21.4** Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile — 6
- ★★★ **21.10** Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos — 14

Practica: Libro Gordo Salud Pública, preguntas 1–2, 14–15, 19–22, 38, 46–48, 56–61.

DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **21.6** Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales — 9
- ★★★ **21.1** Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial — 3
- ★★☆ **21.15** Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección — 8

Practica: Libro Gordo Salud Pública, preguntas 3–12, 18, 29–37, 41–43, 55, 73.

DÍA 3

3 temas · ★★

- ★★☆ **21.9** Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos — 13
- ★★☆ **21.14** Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas — 18
- ★★☆ **21.2** Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos — 4

Practica: Libro Gordo Salud Pública, preguntas 13, 39, 52–54, 83–90.

DÍA 4

2 temas · ★★

- ★★☆ **21.8** Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC — 12
- ★☆☆ **21.5** Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario — 7

Practica: Libro Gordo Salud Pública, preguntas 16–17, 23–28, 45, 49–51.

DÍA 5

2 temas · ★

- ★☆☆ **21.3** Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) — 5
- ★☆☆ **21.11** Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento — 15

Practica: Libro Gordo Salud Pública, preguntas 44, 62–67.

DÍA 6

2 temas · ★

- ★☆☆ **21.13** Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia — 17
- ★☆☆ **21.12** Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad — 16

Practica: Libro Gordo Salud Pública, preguntas 40, 68–72, 74–82.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» pág. 19
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 21.1 · 21.4 · 21.6 · 21.7 · 21.10
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Salud Pública en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 5 temas

32 21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud 11
20 21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile 6
19 21.10. Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos 14
18 21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales 9
13 21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial 3

★★ Prioridad media · 5 temas

10 21.15. Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección 8
10 21.9. Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos 13
10 21.14. Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas 18
9 21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos 4
8 21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC 12

★ Prioridad baja · 5 temas

6 21.5. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario 7
4 21.3. Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) 5
4 21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento 15
3 21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia 17
1 21.12. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad 16